

Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte (SIMR) — L2

Diapositive 1

KOUASSI LOBOH FELICITE

Sage Femme Spécialiste en Santé Publique

Enseignante à l'INFAS d'Abidjan

Responsable de la filière Santé Publique

Ecole de Spécialité

Cél

:

07 899 833 22

Diapositive 2

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 3

SURVEILLANCE INTEGREE
DE LA MALADIE ET RIPOSTE (SIMR)
2024-2025, Semestre 1
CELLLE PEDAGOGIQUE DE SANTE PUBLIQUE
ECOLE DE BASE-INFAS ABIDJAN

Diapositive 4

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/

Mtc

de la L2

=>

d'effectuer la surveillance intégrée des maladies et d'organiser la riposte

.

Diapositive 5

Objectifs spécifiques (1/2)

Au terme de l'enseignement, il doit être capable de :

Définir les concepts en matière de surveillance
épidémiologique

.

Citer les objectifs de la SIMR

Citer les maladies prioritaires sous surveillance

Définir les cas de maladie sous surveillance pour la notification.

Diapositive 6

Plan du cours (1/3)

INTRODUCTION

DEFINITION DES CONCEPTS

OBJECTIFS DE LA SIMR

LES MALADIES PRIORITAIRES SOUS SURVEILLANCE

DEFINITIONS DE CAS DE MALADIE SOUS SURVEILLANCE POUR NOTIFICATION

CONCLUSION

Diapositive 7

Introduction(1/4)

Le monde et singulièrement la région Africaine de l'OMS durant la décennie passée a dû faire face à plusieurs épidémies de choléra, de méningite à méningocoques, de typhoïde et de grippe, et plus récemment , à une épidémie de la maladie à virus Ebola et à la maladie à coronavirus avec des taux de morbidité et de mortalité très élevés.

Diapositive 8

Introduction(2/4)

Malheureusement, les pays dont

les systèmes de surveillance

sont peu performants ne sont pas à mesure de

détecter les menaces

pour la santé publique ou les évènements de santé publique afin

d'y répondre à temps voulu

.

Diapositive 9

Introduction(4/4)

En Côte d'Ivoire, plusieurs maladies sont sous surveillance(

52

).(

faire afficher le document

excel

)

Dans ce chapitre, nous ne décrivons que quelques-unes (08)comme suite:

Diapositive 10

Introduction(4/4)

La Paralyse Flaccide Aigue (PFA)

La Poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage

La poliomyélite due à un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale

Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS)

Diapositive 11

Introduction(4/4)

La rougeole

La fièvre jaune(FJ)

Le tétanos néonatal (TNN)

La maladie à coronavirus ou COVID-19

Diapositive 12

I. Définition des concepts 1/8

la Surveillance

La surveillance est un processus de collecte systématique, organisé et continu de données de santé ainsi que leur analyse, interprétation et dissémination dans une perspective d'aide à la décision et d'évaluation.

Diapositive 13

I. Définition des concepts 2/8

La Surveillance intégrée de la maladie et réponse (SIMR)

Selon le Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la région africaine(2019)

, la SIMR

est une stratégie adoptée par les pays de la Région africaine de l'OMS pour mettre en œuvre des systèmes complets de surveillance de la santé publique et de riposte pour les maladies

,

affections

et

événements prioritaires

à tous les niveaux notamment au niveau communautaire et national.

Diapositive 14

I. Définition des concepts 3/8

La Définition de cas

C'est un ensemble de critères cliniques et ou de laboratoire utilisés pour déterminer si une personne est atteinte d'une maladie particulière.

Diapositive 15

I. Définition des concepts 3/8

La Définition de cas clinique

C'est un ensemble de critères (symptômes) permettant de poser un diagnostic pour un traitement susceptible de sauver la vie du patient.

Diapositive 16

I. Définition des concepts 4/8

La Définition de cas épidémiologique

C'est un ensemble de critères qui permettent de préciser les maladies qui doivent être notifiées pour la surveillance.

1.6. Classification des cas

C'est une technique qui permet classer les cas de maladies en fonction du degré de certitude du diagnostic, l'on distingue les cas suspects, les cas probables, les cas confirmés.

Diapositive 17

I. Définition des concepts 4/8

Classification des cas

C'est une technique qui permet classer les cas de maladies en fonction du degré de certitude du diagnostic. On distingue:

les

cas suspects

;

cas probables

, et les

cas confirmés

.

Diapositive 18

I. Définition des concepts 5/8

Seuil épidémique

C'est la valeur attendue de cas d'une maladie constituant un niveau qui une fois franchi doit attirer l'attention du personnel de santé sur l'émergence d'un phénomène épidémique nécessitant des interventions urgentes.

Diapositive 19

I. Définition des concepts 6/8

Seuil d'alerte

C'est le niveau à partir duquel la notification d'une menace d'épidémie est faite aux autorités sanitaires.

Seuil d'action

C'est le niveau à partir duquel la
riposte
doit être
déclenchée
face à une menace d'épidémie.

Diapositive 20

I. Définition des concepts 7/8

La Riposte

C'est un ensemble d'actions mises en œuvre pour résoudre un problème ou modifier une situation non satisfaisante

Diapositive 21

I. Définition des concepts 8/8

La Notification de cas

C'est la

communication obligatoire

à l'autorité sanitaire de cas et décès dus aux maladies transmissibles ou autres affections importantes du point de vue de la santé publique.

Diapositive 22

II. Objectifs de la SIMR

Surveiller

les tendances

des maladies ;

Détecter précocement des

situations inhabituelles

;

Faciliter la réponse fondée sur des

bases factuelles

.

Diapositive 23

III. Les maladies prioritaires sous surveillance

Les maladies à

potentiel épidémique

(choléra, la COVID-19, la FHV).

Les maladies faisant

l'objet de mesure d'élimination et d'éradication

: la poliomyélite à PVS, VDG etc...

Les maladies cible du

Programme Elargi de vaccination (PEV):

PFA, rougeole, TNN, FJ....

Diapositive 24

IV.

Définitions de cas de maladie sous surveillance pour notification

Diapositive 25

Plan du chapitre (1/2)

4.1. LA PARALYSIE FLASQUE AIGUE (PFA)

4.2. LA POLIOMYELITIS DUE A UN POLIOVIRUS DE TYPE SAUVAGE

4.3. LA POLIOMYELITIS DUE A UN POLIOVIRUS DERIVE D'UNE SOUCHE VACCINALE (PVDVc

)

4.4. SYNDROME RESPIRATOIRE AIGUE SEVERE (SRAS)

Diapositive 26

Plan du chapitre (2/2)

4.5. LA ROUGEOLE

4.6. LA FIEVRE JAUNE

4.7. LE TETANOS NEONATAL

4.8. LA MALADIE A CORONAVIRUS OU COVID-19

Diapositive 27

4.1. La paralysie flasque aigue (PFA)

4.1.1. Définition de cas

Au niveau de la structure sanitaire

C'est tout enfant présentant une faiblesse ou une diminution ou une perte du tonus musculaire touchant n'importe quel muscle du corps, principalement les muscles des bras et/ou des jambes et survenant de façon brutale.

Diapositive 28

4.1. La paralysie flasque aigue (PFA)

4.1.1 Définition de cas (suite)

Au niveau communautaire

C'est tout enfant chez qui l'on constate une apparition soudaine d'une maladie paralytique aigue.

Diapositive 29

4.1. La paralysie flasque aigue

4.1.2 Gestes à faire devant un cas de PFA

Notifier immédiatement le cas au autorités sanitaires du district (CSE, CSAS, DD);

Recueillir

2 échantillons

de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24 à 48 heures, dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie ;

Diapositive 30

4.1. La paralysie flasque aigue

4.1.2 Gestes à faire devant un cas de PFA(suite)

Empaqueter suffisamment les échantillons de selles dans un récipient en matière plastique propre, étanche et fermé par couvercle à vis et expédier dans un porte vaccins entre +2°C à + 8°C ;

Acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 3 jours après collection.

Diapositive 31

Tableau récapitulatif des activités urgentes à mener et les délais d'exécution devant un cas de PFA

Activités à mener

Délai de prélèvement

Entre

J0

et

J14

Entre

J14

et

J60

Entre

J61

et

06 mois

> 06

mois

Prélèvement de selles

X

X

Notification avec diagnostic provisoire

X

X

X

Investigation avec fiche

X

X

X

Diapositive 32

Tableau récapitulatif des activités urgentes à mener et les délais d'exécution devant un cas de PFA

Activités à mener

Délai de prélèvement

Entre

J0

et J14

Entre

J14

et

J60

Entre

J61

et

06 mois

> 06

mois

Inscription du code EPID dans la Base PFA

X

X

X

Examen du 60ième jour

X

Analyse et actions correctrices

X

X

X

Diapositive 33

4.1. La paralysie flasque aigue

4.1.3 Indicateurs de surveillance des PFA

Le taux de PFA est dit

non poliomyélitique

lorsque le nombre de cas de PFA est

"e 2 pour 100 000

enfants de moins de 15 ans

La proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être "e à 80%

Diapositive 34

4.2. La poliomyélite due a un poliovirus de type sauvage

4.2.1 Définition de cas pour la notification de la poliomyélite due un virus de type sauvage

Selon le règlement sanitaire internationale (RSI) 2005, un cas de poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage qui doit être notifié est défini comme

un cas présumé

,

En d'autres termes,

Diapositive 35

4.2. La poliomyélite due a un poliovirus de type sauvage
comprendre qu'un poliovirus de type sauvage a
été trouvé
dans les échantillons de selles de
ce cas
ou dans ceux d'un de ces
contacts proches

.

Diapositive 36

4.2 La poliomyélite due a un poliovirus de type sauvage

4.2.2. Définition de cas présumé

Un cas présumé est tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aigue ou toute personne

quel que soit son âge

présentant une maladie paralytique et chez qui l'on soupçonne une poliomyélite.

Diapositive 37

4.2 La poliomyélite due a un poliovirus de type sauvage

4.2.3. Procédure standard pour le recueil des selles selon le règlement sanitaire international (RSI)

Elle consiste à recueillir

02

échantillons

de selles

d'un cas de PFA dans les

14 jours

qui

suivent l'apparition de la paralysie.

Diapositive 38

4.2.3. Procédure standard pour le recueil des selles selon le RSI(suite)

Si l'on dispose de
moins de
02
échantillons
de selles dans les
14 jours
suivant l'apparition de la paralysie,
recueillir
, des échantillons de
selles supplémentaires
provenant
de
cinq contacts proches du cas
de PFA pour
accroître
la
sensibilité
de la
détection virale.

Diapositive 39

4.3. La poliomyélite due à un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale (PVDVc)

C'est lorsque la souche vaccinale excrétée, continuant de circuler sur une durée prolongée subit une mutation génétique pour devenir un poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale capable de provoquer une paralysie flasque aiguë dans les communautés ayant une très faible immunité.

Diapositive 40

4.4. Syndrome respiratoire aigue sévère(1/4)

1. Définition de cas pour la notification du SRAS

En vertu du RSI (2005), dans

la période qui suit une flambée

du SRAS, un cas de SRAS

qui doit être notifié

est défini comme étant :

le cas d'un sujet avec une confirmation au laboratoire d'une infection par le coronavirus dû SRAS.

Diapositive 41

4.4. Syndrome respiratoire aigue sévère (2/4)

soit a travaillé dans un laboratoire manipulant des coronavirus du SRAS vivant ou conservant des échantillons infectés par le coronavirus du SRAS,

soit correspond à la

définition clinique

du cas de SRAS.

Diapositive 42

4.4. Syndrome respiratoire aigue sévère(3/4)

2. Définition d'un cas clinique SRAS

01 cas

clinique

de SRAS est défini chez toute personne ayant:

Des antécédents de fièvre ou une fièvre documentée,

Un ou plusieurs symptômes d'une affection des voies respiratoires inférieures (toux, difficulté respiratoire, essoufflement)

Diapositive 43

4.4. Syndrome respiratoire aigue sévère(4/4)

Des signes radiographiques d'une pneumonie ou d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA), ou des résultats d'autopsie correspondant à la pneumonie ou du SDRA sans qu'il ait de cause identifiable,

Aucun autre diagnostic ne pouvant expliquer la maladie.

Diapositive 44

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 45

4.5. La rougeole(1/9)

1. Définition de cas pour la notification

Au niveau de la structure sanitaire

Cas suspect de rougeole

C'est est un enfant présentant une

Fièvre

, une

éruption

, une

toux

ou un coryza ou une

conjonctivite

ou toute personne chez qui un clinicien suspecte la rougeole.

Diapositive 46

4.5. La rougeole(2/9)

Cas confirmé de rougeole

C'est un cas suspect avec

IgM

positif

ou cas suspect avec notion de contact physique avec un cas confirmé (

lien épidémiologique

) dans les jours ayant précédé le début de la maladie ou cas suspect confirmé cliniquement.

Diapositive 47

4.5. La rougeole(3/9)

1. Définition de cas pour la notification

Au niveau communautaire

C'est toute personne présentant une chaleur corporelle et une éruption cutanée étendue sur le visage et le corps.

Diapositive 48

4.5. La rougeole(4/9)

2. Définition de Suspicion et de confirmation d'une épidémie

Suspicion d'une épidémie

C'est lorsque cinq (05) cas suspects ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé.

Diapositive 49

4.5. La rougeole(5/9)

Confirmation d'une épidémie

C'est lorsque trois (03) cas confirmés ou + sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé avec notion de lien épidémiologique.

Diapositive 50

4.5. La rougeole(6/9)

3. Organisation de la riposte devant un cas suspect de rougeole.

Prélever le sang entre le 4ème et le 28ème jour après le début de l'éruption ;

Laisser décanter dans un porte vaccin où sont disposés des accumulateurs congelés (+2 et + 8) ;

Diapositive 51

4.5. La rougeole(7/9)

Fermer le porte vaccin ;

Accompagner le prélèvement de la fiche d'enquête

Acheminer le porte vaccin au district sanitaire ou à la DCPEV.

NB

: Faire un prélèvement de gorge des cas entre J1 à J7.

Diapositive 52

4.5. La rougeole(8/9)

4. Mesures préventives

Limiter l'extension de la PEC des cas et contacts

:

Si cas suspect

: Traitement adéquat et limitation de contact entre sujets vaccinés et sujet ayant fait maladie.

Si cas confirmé

: Hospitalisation, traitement adéquat,

Diapositive 53

4.5. La rougeole(9/9)

limitation de contact entre sujets vaccinés et ayant

Si sujet contact

: Vaccination, Isolement dès apparition des 1ers signes.

Vacciner tout cas suspect de rougeole (vaccination sélective);

Diapositive 54

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 55

4.6. Fièvre jaune(1/6)

1. Au niveau de la formation sanitaire.

Cas suspect :

C'est tout sujet présentant une fièvre d'apparition brusque avec ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

Diapositive 56

4.6. Fièvre jaune(2/6)

1.

Au niveau de la formation sanitaire.

Cas probable :

C'est tout cas suspect

IgM

avec histopathologie du foie positive ou lien épidémiologique avec un cas confirmé chez un sujet non vacciné dans les 30 jours.

Diapositive 57

4.6. Fièvre jaune(3/6)

Cas confirmé :

C'est tout cas probable positif à la recherche d'anticorps spécifique

IgM

et

IgM

négatif aux autres flavivirus par un laboratoire certifié.

Diapositive 58

4.6. Fièvre jaune(4/6)

2.

Au niveau communautaire.

C'est toute personne présentant un jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines, avec ou sans chaleur corporelle.

Diapositive 59

4.6. Fièvre jaune(5/6)

3

.

Définition d'une épidémie de Fièvre Jaune.

Il y a

épidémie

de fièvre jaune lorsqu'au moins

un

cas suspect est confirmé au laboratoire.

4. Gestes à faire devant un cas suspect de fièvre jaune

Entreprendre une investigation clinique, épidémiologique et entomologique.

Diapositive 60

4.6. Fièvre jaune (6/6)

4. Gestes à faire devant un cas suspect de fièvre jaune

Identifier la zone concernée et les personnes à risque

Organiser une vaccination de masse réactive selon les conclusions de l'investigation

Initier des mesures de lutte anti vectorielle.

Diapositive 61

TETANOS NEANATAL (TNN)

Diapositive 62

4.7. Tétanos néonatal (1/7)

1.

Définition de cas pour la notification

Cas suspect :

Tout cas de décès néonatal survenu entre le

3ème

et le

28ème

jour de la vie et dont la cause est inconnue

ou

Tout nouveau-né ayant souffert ou signalé avoir souffert du tétanos entre le 3ème et le 28ème jour de la vie mais n'ayant pas

Diapositive 63

4.7. Tétanos néonatal (2/7)

fait l'objet d'une enquête.

Cas confirmé:

C'est tout nouveau-né ayant présenté une aptitude normale à téter et à crier pendant les 2 premiers jours de la vie et ne pouvant plus téter normalement entre le 3ème et le 28ème jour ou tout nouveau-né qui devient raide et/ou a des convulsions

.

NB : La classification des cas de tétanos néonatal est purement clinique et ne dépend d'un test biologique.

Diapositive 64

2. Éléments à rechercher dans l'investigation d'un cas de TNN

Statut vaccinal de la mère ;

Nombre et dates des consultations prénatales ;

Lieu accouchement (maternité, domicile) ;

Responsable de l'accouchement (AT ; PS; autre...)

Diapositive 65

Cordon ombilical : état des instruments utilisés pour section, pansement à domicile ? utilisation de produits traditionnels ?

Évolution du cas : décédé, vivant, inconnu;

Réponse au cas (décrire les actions menées).

Voir fiche de notification

Diapositive 66

3. Gestes à faire devant un cas de tétanos néonatal

Notifier sans tarder au district sanitaire ou à la DCPEV ;

Pas de prélèvement à faire

;

Référer le cas à l'hôpital du district pour une prise en charge ;

Investiguer pour identifier les facteurs associés à la survenue du cas (cas et communauté).

Diapositive 67

Si cas confirmé
après investigation

Administrer

2 doses

du vaccin antitétanique à l'intervalle d'un mois à toutes les femmes en âge de reproduction(FAR)
vivant dans la même habitation que le cas;

Organiser dans la localité des activités de vaccination

Diapositive 68

supplémentaire

en deux (02) passages à l'intention de toutes les FAR (Riposte avec rapport) ;

Eduquer les FAR quant à la nécessité de couper et de soigner le cordon en observant de bonnes conditions d'hygiène. Accoucher dans un centre de santé.

Améliorer la couverture vaccinale de routine du Td.

Diapositive 69

La maladie a coronavirus ou covid-19

Diapositive 70

4.8. La maladie a coronavirus ou covid-19

1. Définition de cas pour notification

Cas suspect de COVID-19(A-B)

A.

C'est une personne qui remplit les
critères cliniques

et

épidémiologiques

Diapositive 71

Critères cliniques:

Apparition soudaine de fièvre et de toux ; OU

Apparition soudaine d'au

moins trois des signes

suivants : Fièvre, toux, faiblesse/fatigue générale, céphalée, myalgie, mal de gorge, coryza, dyspnée, anorexie/nausées/vomissements, diarrhée, altération de l'état mental.

Diapositive 72

Critères épidémiologiques:

Séjour ou travail dans une zone à haut risque de transmission du virus (Établissements résidentiels clos, camps ou centre d'accueil pour les personnes déplacées) à tout moment au cours des 14 jours précédents l'apparition des symptômes.

Diapositive 73

Séjour ou voyage dans une zone de transmission communautaire à tout au cours des 14 précédents l'apparition des symptômes

Travaille dans le secteur de soins de santé, y compris dans les établissements de santé ou dans la communauté, à tout moment au cours des 14 jours précédents l'apparition des symptômes

Diapositive 74

Cas suspect de COVID-19(A-B)

B

. C'est un patient présentant une infection respiratoire aigüe sévère en présence d'antécédents de fièvre ou d'une fièvre mesurée $\geq$ ou $=$ à 38° et de toux, apparue au cours des 10 derniers jours et nécessitant une hospitalisation.

Diapositive 75

Cas probable de COVID-19(A-B-C-D)

A.

C'est un patient qui remplit les critères cliniques ci-dessus

ET

qui a été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19

ou

qui a été relié sur le plan épidémiologique à un groupe de cas dans lequel il y a eu au moins un cas confirmé

Diapositive 76

Cas probable de COVID-19(A-B-C-D)

B

. C'est un cas suspect pour lequel une
imagerie thoracique
révèle des observations indicatives de la COVID-19

C

./ C'est une personne atteinte d'
anosmie
(perte de l'odorat) ou d'
agueusie
(perte du goût) en l'absence de toute autre cause identifiée.

Diapositive 77

Cas probable de COVID-19(A-B-C-D)

D

.

C'est un décès, sans autre explication, d'un adulte qui a présenté une détresse respiratoire

avant le décès

ET

qui a été

en contact avec un cas probable

ou confirmé de COVID-19

ou

qui est

relié

sur le

plan épidémiologique

à un groupe de cas dans lequel il y a eu au moins un cas confirmé.

Diapositive 78

Cas confirmé de COVID-19

C'est une personne présentant une infection par le virus de la COVID-19 confirmée en laboratoire, quels que soient les signes et symptômes cliniques.

Diapositive 79

Conclusion

(1/2)

La détection des cas de maladies et leur notification à travers la surveillance est une stratégie très importante en santé publique. Elle permet de signaler à temps à l'autorité compétente les cas pour prendre des décisions afin de limiter les flambées d'épidémies.

Diapositive 80

Conclusion

(2/2)

Le système de surveillance des pays doit être efficace et performant. De ce préalable dépendra la validation des progrès vers l'élimination de la rougeole, le maintien de l'élimination du TNN et le contrôle la fièvre jaune.

Diapositive 81

(pas de texte extrait sur cette diapositive)